Estilo UERJ

Simulado 6
Caderno

Prova inédita no formato da UERJ: quatro alternativas, casos longos e a armadilha da banca em cada questão.

50 questões

17 de outubro de 2026

ANTES DE COMEÇAR

Instruções

- São 50 questões de Clínica Médica, com quatro alternativas cada (A a D) e uma única correta.
- Tempo sugerido: 2 horas e 30 minutos, sem consulta, de uma vez só.
- Marque as respostas na folha de respostas da última página, e só depois abra a resolução.
- Nas questões de identificar, faça o teste do resto: liste os achados e veja se a hipótese explica todos. Antes de pedir exame ou tratamento, pergunte qual é o degrau mais simples que resolve e o que o paciente já usa.
- Na correção, anote em qual arma da banca você caiu. É isso que vai para o diagnóstico, não o total.

1 Homem de 34 anos, assintomático, procura o ambulatório após exame admissional. O pai teve infarto aos 46 anos e um tio paterno morreu subitamente aos 50. Não fuma, IMC 24 kg/m², PA 122×76 mmHg. Exame: espessamento nodular dos tendões de Aquiles e dos extensores dos dedos das mãos e arco corneano incompleto. Exames em jejum, repetidos: colesterol total 352 mg/dL, LDL-c 271 mg/dL, HDL-c 48 mg/dL, triglicerídeos 110 mg/dL, glicemia 88 mg/dL; TSH 8,9 mUI/L (VR 0,4 a 4,5), T4 livre 1,0 ng/dL (VR 0,7 a 1,8), anti-TPO positivo em título alto; creatinina, enzimas hepáticas, albumina e urina normais. Além de orientar dieta, a conduta para o paciente e a conduta para a família são, respectivamente:

A) Estatina de alta potência / rastrear parentes de 1º grau

B) Estatina de alta potência / sem rastreio familiar

C) Levotiroxina e repetir lipídios / rastrear parentes

D) Levotiroxina e repetir lipídios / sem rastreio familiar

---

2 Mulher de 34 anos tem há 10 semanas placas eritematoedematosas pruriginosas quase diárias, cada uma durando menos de 24 horas e desaparecendo sem deixar marca, com episódios ocasionais de edema palpebral. Sem febre, artralgia, perda de peso ou dor óssea. Não identifica desencadeante e nega uso de anti-inflamatórios. Usa loratadina 10 mg/dia há 6 semanas, com melhora parcial e escore de atividade semanal (UAS7) de 24. Traz hemograma, VHS, PCR e TSH normais. O próximo passo mais adequado é:

A) Prednisona contínua em dose baixa

B) Iniciar omalizumabe subcutâneo

C) Pesquisar FAN, anti-TPO e parasitas

D) Aumentar a loratadina até 40 mg/dia

---

3 Homem de 52 anos, com sequela de tuberculose tratada há 10 anos (cavidade residual no lobo superior direito), chega à emergência após expectorar cerca de 400 mL de sangue vivo nas últimas 3 horas. Está acordado e ansioso, fala frases curtas e tem nova golfada de sangue durante o exame. PA 128 × 80 mmHg, FC 112 bpm, SpO2 89% em ar ambiente, estertores grossos em todo o hemitórax direito, com o esquerdo limpo. Não usa anticoagulante; plaquetas e coagulograma normais. A equipe de radiologia intervencionista chega em 40 minutos. Enquanto se oferece oxigênio e se obtém acesso venoso, a primeira medida é:

A) Decúbito lateral sobre o lado direito

B) Broncoscopia flexível à beira do leito

C) Angiotomografia de tórax imediata

D) Ácido tranexâmico e observação

---

4 Homem de 41 anos, trabalhador de fazenda de cacau no sul da Bahia, em área de mata, chega ao PS 2 horas após ser picado na perna direita por serpente que não conseguiu ver bem. Refere dor intensa no local. Exame: edema do pé até o joelho, equimose e duas bolhas próximas à picada; sem ptose, sem diplopia, sem fácies miastênica. Há 40 minutos tem cólicas abdominais, três episódios de diarreia e vômitos, com sudorese profusa. FC 46 bpm, PA 84 × 50 mmHg, FR 20 irpm. Tempo de coagulação: incoagulável. CK 310 U/L, urina de cor normal. O gênero da serpente mais provável é:

A) Crotalus

B) Lachesis

C) Micrurus

D) Bothrops

---

5 Homem de 61 anos, com diabetes tipo 2 há 20 anos (HbA1c 8,4%) e neuropatia periférica (monofilamento não percebido em ambos os pés), procura atendimento porque há 10 dias o pé direito ficou inchado, quente e vermelho após uma torção leve ao descer da calçada. Refere apenas desconforto discreto e continua andando normalmente. Nega febre. Exame: pé direito edemaciado e eritematoso no mediopé, temperatura cutânea 3,2 °C maior que a do pé esquerdo, pele íntegra, sem úlcera ou porta de entrada entre os dedos, pulsos pediosos amplos; o eritema desaparece após elevação do membro por 5 minutos. Leucócitos 7.800/mm³, PCR 6 mg/L (VR até 5). Radiografia do pé com carga: sem fratura, sem erosão ou luxação. A conduta mais adequada neste momento é:

A) Ressonância do pé antes de imobilizar

B) Gesso de contato total

C) Biópsia óssea antes de tratar

D) Antibiótico oral para celulite

---

6 Homem de 54 anos, hipertenso e dislipidêmico, em uso de losartana e atorvastatina, ex-tabagista há 10 anos, é encaminhado por hematócrito alto em exame de rotina. Refere cefaleia leve e prurido após o banho há 1 ano. Nunca teve trombose, AVC ou infarto. Exame: PA 128 × 80 mmHg, pletora facial, baço palpável a 2 cm do rebordo costal. Hemograma: Hb 18,9 g/dL, hematócrito 57%, leucócitos 11.200/mm³, plaquetas 640.000/mm³. SpO2 97% em ar ambiente, eritropoetina sérica baixa e mutação JAK2 V617F positiva. O colega que o encaminhou sugere iniciar hidroxiureia por causa das plaquetas e do risco cardiovascular. A conduta mais adequada é:

A) Ruxolitinibe, flebotomias e AAS

B) Flebotomias (hematócrito abaixo de 50%) e AAS

C) Hidroxiureia, flebotomias e AAS

D) Flebotomias (hematócrito abaixo de 45%) e AAS

---

7 Homem de 47 anos, etilista de cerca de 120 g de álcool por dia há 15 anos, com última dose há 5 dias, procura o pronto-socorro por icterícia progressiva há 3 semanas. Exame: Tax 37,7 °C, FC 98 bpm, PA 118 × 74 mmHg, icterícia 2+/4+, hepatomegalia dolorosa, sem ascite ao exame, sem flapping. Exames: bilirrubina total 4,0 mg/dL, AST 210 U/L, ALT 82 U/L, GGT 640 U/L, tempo de protrombina 17 s (controle 12 s), INR 1,6, albumina 3,0 g/dL, creatinina 0,9 mg/dL, sódio 134 mEq/L, leucócitos 13.500/mm³. MELD 18. Hemoculturas, urocultura e radiografia de tórax sem alterações. Ultrassonografia: fígado aumentado e hiperecogênico, sem dilatação de vias biliares. A conduta mais adequada é:

A) Pentoxifilina 400 mg três vezes ao dia

B) Prednisolona com N-acetilcisteína intravenosa

C) Prednisolona 40 mg/dia por 28 dias

D) Abstinência e suporte nutricional

---

8 Homem de 29 anos é encaminhado por infecções respiratórias de repetição desde os 22 anos: quatro pneumonias com internação, sinusites a cada 2 ou 3 meses e otites médias. Há 1 ano tem diarreia aquosa crônica, com perda de 6 kg; o parasitológico mostrou Giardia lamblia, tratada duas vezes, com recidiva. Nunca fumou. Sem consanguinidade entre os pais, sem infertilidade conhecida. Exame físico: IMC 19 kg/m², estertores em bases, baqueteamento digital discreto e baço palpável a 2 cm do rebordo costal. TC de tórax: bronquiectasias cilíndricas em lobos inferiores. Hemograma: leucócitos 6.200/mm³ (linfócitos 1.400/mm³), plaquetas 140.000/mm³. Anti-HIV (quarta geração) não reagente. Eletroforese de proteínas séricas: albumina 3,8 g/dL, fração gama 0,3 g/dL (VR 0,7 a 1,6). O próximo exame mais adequado é:

A) Teste do suor com dosagem de cloro

B) Dosagem sérica de IgG, IgA e IgM

C) Dosagem sérica de alfa-1 antitripsina

D) Biópsia de mucosa nasal para cílios

---

9 Homem de 41 anos, com infecção pelo HIV diagnosticada há 10 dias (CD4 de 62 células/mm³), está internado há 6 dias por pneumonia intersticial bilateral com PaO2 de 64 mmHg em ar ambiente e LDH elevada, tratado com o esquema de primeira linha para o agente mais provável, em dose plena, associado a prednisona. Hoje refere fraqueza leve. PA 118/74 mmHg, FC 88 bpm, sem hiperpigmentação. Exames: potássio 6,3 mEq/L (4,1 mEq/L na admissão), sódio 134 mEq/L, cloro 108 mEq/L, bicarbonato 19 mEq/L, creatinina 1,3 mg/dL (1,0 mg/dL na admissão), glicose 132 mg/dL; cortisol sérico às 8 h, colhido na admissão, de 21 mcg/dL. ECG com ondas T apiculadas, sem alargamento do QRS. Não usa IECA, BRA, espironolactona nem heparina. O mecanismo principal da hipercalemia é:

A) Insuficiência adrenal por citomegalovírus

B) Bloqueio do canal epitelial de sódio

C) Nefrite intersticial aguda por sulfonamida

D) Redistribuição pela acidose metabólica

---

10 Homem de 41 anos, professor, em relação monogâmica com a esposa há 12 anos, procura ambulatório por febre diária até 38,6 °C há 3 semanas, astenia e sudorese. Nega dor de garganta, uso de medicamentos e viagens. Exame: bom estado geral, orofaringe sem exsudato, linfonodos cervicais de 1 cm, discretos, baço palpável a 2 cm do rebordo costal. Hemograma: leucócitos 11.800/mm³, 61% de linfócitos, 16% de linfócitos atípicos; plaquetas 128.000/mm³. ALT 168 U/L, AST 140 U/L, FA 190 U/L. Anticorpo heterófilo (monoteste) negativo no 7º e no 20º dia. Sorologias: anti-VCA IgM não reagente, anti-VCA IgG e anti-EBNA IgG reagentes; toxoplasmose IgG reagente e IgM não reagente; anti-HIV de 4ª geração não reagente. O agente etiológico mais provável é:

A) Citomegalovírus

B) Vírus Epstein-Barr

C) HIV, na infecção aguda

D) Toxoplasma gondii

---

11 Homem de 46 anos, tabagista, procura o pronto-socorro às 2 h da madrugada com a terceira crise do dia de dor excruciante em torno do olho direito, com lacrimejamento, rinorreia e ptose à direita; anda de um lado para o outro e não consegue ficar deitado. Há três semanas tem crises iguais, de 45 a 90 minutos, quase todas noturnas; teve um período idêntico há dois anos, que cessou sozinho em 2 meses. Usa AAS 100 mg/dia, ticagrelor 90 mg de 12/12 horas, rosuvastatina e metoprolol desde uma internação há 8 meses. PA 138/86 mmHg, FC 64 bpm, SpO2 97%. Exame neurológico normal entre as crises. Para abortar a crise atual, a medida mais adequada é:

A) Sumatriptana 6 mg subcutânea

B) Oxigênio a 100% sob máscara

C) Prednisona 60 mg por via oral

D) Verapamil 80 mg por via oral

---

12 Mulher de 79 anos, hipertensa há 30 anos, tem dispneia aos moderados esforços e um episódio de pré-síncope ao subir ladeira há 2 meses. Usa anlodipino e losartana, com PA bem controlada em casa. Exame: PA 128×74 mmHg, FC 72 bpm, ritmo regular, pulso carotídeo de ascensão lenta, sopro sistólico ejetivo 3+/6+ em foco aórtico com B2 hipofonética. Ecocardiograma transtorácico, com medidas revisadas por um segundo examinador: ventrículo esquerdo pequeno com septo de 14 mm, fração de ejeção de 64%, área valvar aórtica de 0,8 cm² (0,48 cm²/m²), velocidade máxima de 3,4 m/s, gradiente médio de 29 mmHg, volume sistólico indexado de 30 mL/m², valva muito calcificada e de mobilidade reduzida. Ritmo sinusal, sem outra valvopatia significativa. Para definir a gravidade da estenose, o próximo exame é:

A) Ecocardiograma de estresse com dobutamina

B) Ecocardiograma transesofágico com planimetria

C) Cateterismo com medida invasiva do gradiente

D) Escore de cálcio valvar por tomografia

---

13 Homem de 24 anos, alto e magro, tabagista de 5 maços-ano, trabalha como mergulhador profissional em plataforma de petróleo. Há 10 dias teve dor torácica súbita à esquerda em repouso; a radiografia mostrou pneumotórax de 2,5 cm na altura do hilo, tratado com aspiração por agulha, com reexpansão completa e alta no mesmo dia. Hoje volta ao ambulatório assintomático, SpO2 98%, radiografia normal. A TC de tórax mostra pequenas bolhas apicais bilaterais, sem cistos difusos nem outras alterações. Foi orientado a parar de fumar e pergunta quando volta a mergulhar. Para prevenir a recorrência, a conduta mais adequada é:

A) Apenas cessação do tabagismo

B) Pleurodese com talco pelo dreno

C) Tomografia anual das bolhas

D) Videotoracoscopia com pleurectomia

---

14 Homem de 58 anos, sem diabetes, procura atendimento por episódios de sudorese, tremor e confusão há 5 semanas, que ocorrem 2 a 3 horas após o almoço e, duas vezes, de madrugada. Em um episódio no pronto-socorro, a glicemia capilar foi de 38 mg/dL, com melhora imediata após glicose venosa. Tem neuropatia periférica atribuída ao alcoolismo pregresso (abstinente há 3 anos) e, há 2 meses, começou por conta própria um suplemento antioxidante vendido em farmácia para "formigamento nos pés". Nega uso de insulina ou de comprimidos para diabetes, e ninguém na casa é diabético. Exame físico sem alterações. Em nova hipoglicemia documentada (glicose plasmática de 42 mg/dL): insulina 1.850 µUI/mL (VR 2 a 25), peptídeo C 6,8 ng/mL (VR 0,9 a 4,0), pesquisa de sulfonilureias no plasma negativa. Tomografia de abdome com contraste sem alterações. A causa mais provável das hipoglicemias é:

A) Insulinoma pancreático

B) Uso sub-reptício de insulina

C) Anticorpos contra a insulina

D) Anticorpos contra o receptor de insulina

---

15 Homem de 52 anos, transplantado renal há 4 anos, em uso de tacrolimo (nível sérico de 6 ng/mL, na faixa-alvo), micofenolato de mofetila e prednisona 5 mg/dia, sem medicação nova há mais de um ano, tem ALT entre 160 e 240 U/L em todas as dosagens dos últimos 5 meses (antes, sempre normal). Está assintomático; não consome álcool. Exames: AST 140 U/L, fosfatase alcalina e bilirrubinas normais, INR 1,0, creatinina estável em 1,3 mg/dL. HBsAg e anti-HBc não reagentes; anti-HCV não reagente e HCV-RNA indetectável; CMV-PCR indetectável; anti-HEV IgM e IgG não reagentes. Ultrassonografia com Doppler hepático normal. O próximo exame mais adequado é:

A) Colangiorressonância magnética

B) HEV-RNA por PCR no sangue

C) FAN e anticorpo antimúsculo liso

D) Biópsia hepática percutânea

---

16 Homem de 54 anos, com fadiga há 5 meses e duas pneumonias tratadas no período, refere peso no hipocôndrio esquerdo. Sem febre atual, sem sudorese noturna, sem linfonodomegalias palpáveis; baço a 12 cm do rebordo costal. Hemograma: Hb 9,4 g/dL, VCM 96 fL, leucócitos 1.900/mm³ (neutrófilos 600, linfócitos 1.300, monócitos 0/mm³), plaquetas 62.000/mm³. Esfregaço: raros linfócitos de tamanho médio com citoplasma amplo; sem dacriócitos, sem eritroblastos e sem precursores mieloides circulantes. LDH normal. A tentativa de aspirado de medula óssea resultou em punção seca. O diagnóstico mais provável é:

A) Leucemia de células pilosas

B) Linfoma esplênico da zona marginal

C) Leucemia linfocítica crônica

D) Mielofibrose primária

---

17 Homem de 57 anos, filho de imigrantes coreanos, tem gota tofácea com quatro crises no último ano, hipertensão e doença renal crônica com taxa de filtração glomerular estimada de 42 mL/min/1,73 m². Usa losartana e anlodipino. Ácido úrico sérico de 9,8 mg/dL. Radiografia dos pés com erosões em saca-bocado no primeiro metatarsofalângico, com bordas escleróticas. O reumatologista decidiu iniciar terapia hipouricemiante com alopurinol e profilaxia com colchicina. Antes de prescrever o alopurinol, o exame mais adequado é:

A) Pesquisa do alelo HLA-B*58:01

B) Atividade da G6PD eritrocitária

C) Ácido úrico em urina de 24 horas

D) Ultrassonografia articular com duplo contorno

---

18 Em adulto imunocompetente com varicela sem complicações, o benefício demonstrado do aciclovir oral (redução da duração da febre e do número de lesões) depende de iniciá-lo, no máximo:

A) Até 24 horas do início do exantema

B) Enquanto houver vesículas novas

C) Até 72 horas do início do exantema

D) Não há benefício no adulto hígido

---

19 Homem de 57 anos, com obesidade (IMC 34 kg/m²), diabetes tipo 2 em uso de metformina e hipertensão, teve cólica renal à esquerda há 10 dias, resolvida com analgésico. A radiografia simples de abdome não mostrou imagem radiopaca. A TC sem contraste mostra cálculo de 11 mm na pelve renal esquerda, com densidade de 380 UH, sem hidronefrose. Hoje está assintomático e afebril. Exames: creatinina 1,0 mg/dL, ácido úrico sérico 6,2 mg/dL; urina de 24 horas com volume de 1,4 L e ácido úrico urinário de 610 mg (normal até 800 mg); pH urinário de 5,0 em três amostras; urocultura negativa. A conduta mais adequada para o cálculo é:

A) Litotripsia extracorpórea

B) Alopurinol 300 mg/dia

C) Ureteroscopia flexível com laser

D) Citrato de potássio oral

---

20 Homem de 71 anos, hipertenso com uso irregular de anlodipino, é trazido ao pronto-socorro 3 horas após cefaleia occipital súbita, vômitos repetidos e incapacidade de ficar de pé. Na admissão estava sonolento, com Glasgow 14; duas horas depois, Glasgow 11 (abertura ocular à voz, confuso, localiza a dor), com paresia do olhar conjugado para a direita e paralisia facial periférica direita. PA 186/102 mmHg, FC 58 bpm. Não usa antitrombóticos; plaquetas 210.000/mm³, INR 1,0. TC de crânio: hematoma no hemisfério cerebelar direito com 3,8 cm de maior diâmetro, apagamento do quarto ventrículo e dilatação dos cornos temporais dos ventrículos laterais. Além do controle pressórico, a conduta mais adequada é:

A) Manitol e nova TC em 6 horas

B) Derivação ventricular externa isolada

C) Evacuação suboccipital do hematoma

D) Ácido tranexâmico intravenoso

---

21 Em mulher de 71 anos, ex-tabagista, assintomática, com aneurisma fusiforme de aorta abdominal infrarrenal acompanhado por ultrassonografia, crescimento de 0,3 cm no último ano e anatomia favorável, o diâmetro máximo a partir do qual se deve considerar o reparo eletivo é:

A) 4,5 cm

B) 5,0 cm

C) 5,5 cm

D) 6,0 cm

---

22 Mulher de 38 anos, asmática desde a infância, piorou no último ano apesar de budesonida-formoterol 400/12 mcg duas vezes ao dia, com técnica adequada e adesão conferida na farmácia. Recebeu três ciclos de prednisona no período e tem expectorado tampões acastanhados. Nega tabagismo e contato com aves. SpO2 96%, sibilos esparsos. Hemograma: eosinófilos 1.100/mm³. IgE total 2.400 UI/mL (referência até 100). TC de tórax: bronquiectasias centrais nos lobos superiores, algumas preenchidas por muco hiperdenso. O médico que a acompanhava já preencheu o formulário para mepolizumabe, por asma eosinofílica grave. O exame a solicitar agora é:

A) IgE específica para Aspergillus

B) Cultura de escarro para fungos

C) Broncoscopia com lavado broncoalveolar

D) Galactomanana sérica e hemoculturas

---

23 Mulher de 58 anos, com hipotireoidismo por tireoidite de Hashimoto, é investigada por anemia macrocítica (Hb 10,1 g/dL, VCM 112 fL) com vitamina B12 sérica de 120 pg/mL. A endoscopia mostra mucosa de corpo e fundo atrófica e três lesões polipoides de 5, 6 e 8 mm no corpo gástrico; o antro é normal. A biópsia das lesões mostra tumor neuroendócrino bem diferenciado, Ki-67 de 1%; a das áreas planas mostra gastrite atrófica de corpo com metaplasia intestinal, e a pesquisa de H. pylori é negativa. Anticorpo anticélula parietal positivo; gastrina sérica de 1.150 pg/mL (referência até 100). A ecoendoscopia mostra lesões restritas à mucosa e submucosa, sem linfonodos, e a TC de abdome não tem lesões hepáticas. Além da reposição de B12, a conduta mais adequada para as lesões é:

A) Análogo de somatostatina de depósito

B) Antrectomia para suprimir a gastrina

C) Ressecção endoscópica e vigilância endoscópica

D) Gastrectomia total com linfadenectomia

---

24 Gestante de 31 anos, G2P1, com 37 semanas, pré-natal sem intercorrências. Plaquetas: 228.000/mm³ no primeiro trimestre, 164.000/mm³ com 28 semanas e, hoje, 84.000/mm³, sem agregados no esfregaço. Na gestação anterior, as plaquetas estavam em 96.000/mm³ no parto e se normalizaram no puerpério. Nega sangramentos, sem petéquias ou equimoses. PA 116/72 mmHg, relação proteína/creatinina urinária 0,1, AST, ALT e LDH normais, bilirrubinas normais, sem esquizócitos. Está planejado parto vaginal com analgesia peridural. O diagnóstico mais provável e a conduta quanto à analgesia são, respectivamente:

A) PTI / prednisona antes da peridural

B) Trombocitopenia gestacional / peridural permitida

C) Trombocitopenia gestacional / peridural contraindicada

D) PTI / imunoglobulina antes da peridural

---

25 Mulher de 63 anos, com osteoporose diagnosticada há 2 meses (T-escore de -2,7 no colo do fêmur), sem fraturas, é encaminhada por PTH elevado. Nega nefrolitíase, uso de lítio ou de tiazídico. Refere dieta pobre em laticínios e pouca exposição solar; usa omeprazol há 6 anos. Exames: cálcio total 9,6 mg/dL (VR 8,5 a 10,2), cálcio iônico 1,22 mmol/L (VR 1,12 a 1,32), albumina 4,1 g/dL, fósforo 2,9 mg/dL, PTH 112 pg/mL (VR 15 a 65), creatinina 0,8 mg/dL (TFG estimada de 78 mL/min/1,73 m²), fosfatase alcalina no limite superior, calciúria de 24 horas 72 mg. Para seguir a investigação, o próximo exame a ser solicitado é:

A) Fosfatase alcalina óssea

B) Cintilografia com sestamibi

C) Ultrassonografia cervical

D) 25-hidroxivitamina D sérica

---

26 Homem de 79 anos, hipertenso, com doença renal crônica (taxa de filtração glomerular estimada de 34 mL/min/1,73 m²), submetido a ressecção transuretral de próstata há 7 semanas, é internado por febre há 3 semanas, astenia e perda de 4 kg. Exame: T 38,2 °C, PA 132 × 70 mmHg, sopro diastólico aspirativo 2+/6 em foco aórtico acessório, sem sinais de insuficiência cardíaca. Três de três hemoculturas: Enterococcus faecalis sensível a ampicilina, sem alto nível de resistência a aminoglicosídeos. Ecocardiograma transesofágico: vegetação de 7 mm na valva aórtica nativa, insuficiência aórtica leve, sem abscesso. Audiometria basal com perda neurossensorial leve. O esquema antimicrobiano e a duração mais adequados são, respectivamente:

A) Ampicilina e gentamicina / 4 semanas

B) Ampicilina e ceftriaxona / 6 semanas

C) Ampicilina e ceftriaxona / 2 semanas

D) Vancomicina e gentamicina / 6 semanas

---

27 Mulher de 41 anos, com epilepsia focal em uso de ácido valproico há 3 anos e transtorno bipolar, teve lamotrigina introduzida há 17 dias pelo psiquiatra, na dose de 50 mg/dia. Usa anlodipino há 4 anos. Há 4 dias teve febre, odinofagia e mal-estar, e tomou dipirona 1 g a cada 6 horas por 2 dias. Há 24 horas surgiram máculas purpúricas e lesões em alvo atípicas planas na face e no tronco, com bolhas flácidas, e erosões nos lábios, na mucosa oral e nas conjuntivas. Nikolsky positivo; o destacamento epidérmico é estimado em 8% da superfície corporal. Tax 38,6 °C, FC 108 bpm, PA 112 × 70 mmHg. O fármaco mais provavelmente responsável é:

A) Ácido valproico

B) Dipirona

C) Lamotrigina

D) Anlodipino

---

28 Mulher de 66 anos está no 10º dia de UTI por choque séptico de foco pulmonar, em ventilação mecânica, nutrição parenteral total desde a admissão e noradrenalina 0,25 mcg/kg/min, que vinha em redução e voltou a subir há 24 horas. Recebe meropenem e vancomicina há 7 dias, com hemoculturas de controle negativas e radiografia de tórax em melhora. Hoje: Tax 38,6 °C, leucócitos 19.800/mm³, bilirrubina total 2,3 mg/dL, fosfatase alcalina 240 U/L. A ultrassonografia à beira do leito mostra vesícula distendida (11 × 5 cm), com parede de 5,5 mm com líquido pericolecístico, lama biliar, sem cálculos e sem dilatação de vias biliares. Quanto ao diagnóstico e à conduta, respectivamente:

A) Colecistite aguda acalculosa / colecistostomia percutânea

B) Colecistite aguda acalculosa / colecistectomia de urgência

C) Lama biliar do jejum / manter e repetir ultrassonografia

D) Lama biliar do jejum / ácido ursodesoxicólico

---

29 Mulher de 86 anos, com doença de Alzheimer avançada, acamada e institucionalizada, é trazida por sonolência progressiva há 3 dias. A cuidadora relata febre e recusa de líquidos há cerca de 5 dias. Usa donepezila e quetiapina. Exame: sonolenta, desperta ao chamado, sem déficit focal, mucosas muito secas, PA 82/50 mmHg, FC 118 bpm, tempo de enchimento capilar de 5 segundos, temperatura 37,9 °C. Exames: sódio 164 mEq/L, potássio 3,8 mEq/L, ureia 112 mg/dL, creatinina 1,7 mg/dL (basal 0,8 mg/dL), glicose 118 mg/dL; EAS com leucocitúria e nitrito positivo. Quanto ao fluido inicial e ao limite de queda do sódio sérico nas primeiras 24 horas, a conduta mais adequada é, respectivamente:

A) SF 0,9% / até 10 mEq/L

B) Soro glicosado a 5% / até 10 mEq/L

C) SF 0,9% / até 20 mEq/L

D) Soro glicosado a 5% / até 20 mEq/L

---

30 Mulher de 44 anos teve, há 10 semanas, fraqueza ascendente simétrica com arreflexia, que atingiu o nadir no 12º dia (não deambulava sem apoio); o líquor mostrou proteína de 148 mg/dL e 3 células/mm³, e a eletroneuromiografia, padrão desmielinizante. Recebeu imunoglobulina humana IV 2 g/kg, com melhora parcial. Na 5ª semana piorou e recebeu novo ciclo, com melhora; na 8ª semana, nova piora, tratada com plasmaférese. Hoje, na 10ª semana, procura o ambulatório com a terceira piora: volta a não subir escadas, com parestesias em luvas e botas e arreflexia global. Sem disautonomia, sem queixas respiratórias (CVF 2,9 L), afebril. Anti-HIV, eletroforese de proteínas com imunofixação e glicemia de jejum normais. O diagnóstico mais provável é:

A) Polineuropatia desmielinizante inflamatória crônica

B) Novo episódio de síndrome de Guillain-Barré

C) Flutuação relacionada ao tratamento com imunoglobulina

D) Síndrome POEMS

---

31 Homem de 24 anos é levado pela mãe para avaliar hipertensão detectada em exame admissional. Teve atraso do desenvolvimento, estudou em escola especial e é descrito como muito comunicativo e afetuoso com estranhos; a mãe lembra que, no primeiro ano de vida, ele foi internado por irritabilidade e vômitos, com 'cálcio alto no sangue'. Ao exame: baixa estatura, nariz curto e arrebitado, lábios grossos, boca larga e íris com padrão estrelado. PA 158×88 mmHg no braço direito e 134×84 mmHg no braço esquerdo; pulsos femorais amplos e simétricos, sem retardo radiofemoral. Frêmito sistólico na fúrcula e sopro sistólico ejetivo rude, mais intenso no 1º espaço intercostal direito e irradiado para as carótidas, sem clique de ejeção; componente aórtico de B2 normal. Creatinina 0,8 mg/dL e potássio 4,2 mEq/L. A lesão cardiovascular mais provável é:

A) Cardiomiopatia hipertrófica obstrutiva

B) Valva aórtica bicúspide estenótica

C) Estenose aórtica supravalvar

D) Coarctação da aorta

---

32 Mulher de 34 anos, negra, faz exame admissional. Hemograma: leucócitos 2.900/mm³ (neutrófilos 1.050, linfócitos 1.500, monócitos 280/mm³), Hb 13,1 g/dL, VCM 88 fL, plaquetas 236.000/mm³, esfregaço sem alterações morfológicas. Assintomática, nega infecções de repetição, úlceras orais, artralgias, perda de peso e uso de medicamentos. Exame físico sem esplenomegalia ou linfonodomegalias. Trouxe hemogramas de 2019, 2022 e 2024, todos com neutrófilos entre 1.000 e 1.300/mm³. A irmã tem "glóbulos brancos baixos". Anti-HIV, HBsAg, anti-HCV, vitamina B12 e TSH normais. Quanto à investigação, o próximo passo mais adequado é:

A) Mielograma com citogenética

B) Nenhum exame, apenas hemograma periódico

C) Pesquisa de anticorpo antineutrófilo

D) Imunofenotipagem para grandes linfócitos granulares

---

33 Mulher de 31 anos, com 24 semanas de gestação, procura a emergência por dispneia aos moderados esforços e dor pleurítica à direita há dois dias. Nega febre e tosse. Sem comorbidades, usa apenas sulfato ferroso. Exame: PA 112 × 70 mmHg, FC 104 bpm, FR 22 irpm, SpO2 95% em ar ambiente, ausculta pulmonar sem alterações. A panturrilha esquerda está 3 cm mais grossa que a direita, com empastamento doloroso. Radiografia de tórax com proteção abdominal: normal. ECG: taquicardia sinusal. D-dímero 1.900 ng/mL. Função renal normal. O exame a solicitar agora e o anticoagulante a usar se o diagnóstico se confirmar são, respectivamente:

A) Angiotomografia de tórax / heparina não fracionada

B) Cintilografia de ventilação e perfusão / enoxaparina

C) Ultrassonografia venosa compressiva / enoxaparina

D) Ultrassonografia venosa compressiva / rivaroxabana

---

34 Homem de 66 anos, hipertenso em uso de enalapril 20 mg/dia há 6 anos, tem leucemia linfocítica crônica diagnosticada há 2 anos, em observação (Binet A). Apresenta o terceiro episódio em 5 meses de edema de lábios e língua, sem prurido e sem urticária, que se resolve em 3 dias. No primeiro episódio recebeu adrenalina intramuscular, prometazina e hidrocortisona, sem resposta. Há 2 meses teve dor abdominal em cólica com vômitos, e a TC mostrou espessamento de alça jejunal que regrediu em 48 horas. Nega casos semelhantes na família. Exames fora da crise: leucócitos 24.000/mm³ (82% linfócitos), C4 de 4 mg/dL (VR 10 a 40), inibidor de C1 quantitativo de 9 mg/dL (VR 21 a 39), C1q de 3 mg/dL (VR 10 a 25). A causa mais provável do angioedema é:

A) Angioedema induzido pelo enalapril

B) Angioedema hereditário tipo I

C) Angioedema histaminérgico recorrente

D) Deficiência adquirida do inibidor de C1

---

35 Na acromegalia ativa de longa duração, a alteração cardíaca estrutural mais frequente ao ecocardiograma, presente mesmo em normotensos, é:

A) Padrão restritivo de aspecto infiltrativo

B) Dilatação com fração de ejeção reduzida

C) Hipertrofia biventricular concêntrica

D) Hipertrofia septal assimétrica obstrutiva

---

36 Homem de 34 anos teve HIV diagnosticado há 1 semana em triagem de banco de sangue. Está assintomático: nega cefaleia, febre, vômitos, alteração visual ou de comportamento. Exame: T 36,8 °C, PA 118 × 76 mmHg, Glasgow 15, sem rigidez de nuca, sem déficit focal, fundoscopia sem papiledema. Exames: CD4 62 células/mm³, carga viral 210.000 cópias/mL, radiografia de tórax normal; TC de crânio sem contraste, feita na triagem, sem lesões. O teste rápido de antígeno criptocócico (CrAg) por fluxo lateral no soro, pedido pela rotina do serviço, foi reagente, com título de 1:320. Ainda não iniciou TARV nem antifúngico. O próximo exame mais adequado é:

A) Repetir o CrAg sérico em 2 semanas

B) RM de encéfalo com gadolínio

C) Punção lombar com pressão de abertura

D) Hemocultura para fungos

---

37 Homem de 24 anos, com rinite alérgica e asma leve em uso de budesonida-formoterol sob demanda, procura o ambulatório após o segundo episódio de impactação de carne no esôfago em um ano; no último, há três semanas, o bolo foi retirado por endoscopia de urgência, que descreveu "mucosa esofágica de aspecto normal, sem estenose", sem biópsias. Relata pirose ocasional e, desde então, usa omeprazol 20 mg/dia, com melhora parcial da pirose, mas segue comendo devagar e bebendo água para "empurrar" a comida. Nega emagrecimento, odinofagia e uso de anti-inflamatórios. Exame físico normal; IMC 23 kg/m². Hemograma com eosinófilos de 620/mm³. O médico assistente mantém o diagnóstico de doença do refluxo gastroesofágico. O próximo exame mais adequado é:

A) Endoscopia com biópsias de esôfago proximal e distal

B) Esofagograma baritado com pastilha de bário

C) Manometria esofágica de alta resolução

D) pHmetria esofágica de 24 horas sem omeprazol

---

38 Homem de 32 anos é encaminhado por proteinúria de 1,1 g/24 h e creatinina de 1,4 mg/dL. Desde a adolescência tem crises de dor em queimação nas mãos e nos pés, desencadeadas por febre e exercício, e quase não transpira; foi rotulado como fibromialgia aos 25 anos. Há 1 ano teve episódio de vertigem súbita, com RM mostrando lesões isquêmicas na substância branca e na circulação posterior. Ecocardiograma com hipertrofia concêntrica do ventrículo esquerdo; PA 124/78 mmHg, sem história de hipertensão. FAN 1:160 padrão pontilhado fino, C3 e C4 normais, EAS com proteinúria e sem hematúria. O oftalmologista descreve opacidades corneanas em redemoinho; ele não usa amiodarona nem cloroquina. O exame mais adequado neste momento é:

A) Anti-DNA nativo e anti-Sm

B) Atividade da alfa-galactosidase A

C) Biópsia renal percutânea

D) Eletroneuromiografia dos membros

---

39 Mulher de 59 anos, com tromboembolismo pulmonar de alto risco (choque à admissão), recebeu alteplase 100 mg em 2 horas; a heparina não fracionada foi suspensa ao iniciar a infusão, há 3 horas. Cinquenta minutos após o término, surge sangramento ativo e volumoso no local da punção arterial femoral feita para gasometria, que não cede à compressão, e hematúria macroscópica. PA 104/66 mmHg, FC 108 bpm, SpO2 94% com cateter nasal. Exames: Hb 9,8 g/dL (12,1 g/dL à admissão), plaquetas 188.000/mm³, INR 1,4, TTPa relação 1,6, fibrinogênio 92 mg/dL (VR 200 a 400). A infusão já terminou e a compressão local continua. Além do antifibrinolítico, a medida hemostática mais adequada neste momento é:

A) Concentrado de plaquetas por aférese

B) Sulfato de protamina endovenoso

C) Crioprecipitado 10 unidades

D) Plasma fresco congelado 15 mL/kg

---

40 Mulher de 36 anos, com migrânea com aura visual desde a adolescência (duas crises por ano, sem profilaxia), procura o pronto-socorro por dor contínua na região cervical esquerda e na hemiface esquerda há 4 dias, diferente das crises habituais, iniciada após uma aula de ioga com extensão cervical prolongada. Hoje teve dois episódios de 10 minutos de fraqueza e dormência na mão direita com dificuldade para encontrar palavras, com recuperação completa. Não fuma e usa anticoncepcional combinado. PA 128/78 mmHg, FC 76 bpm, ritmo regular. Exame neurológico atual sem déficit motor ou de linguagem; pupila esquerda de 2 mm e direita de 4 mm, com ptose discreta à esquerda e sudorese facial preservada. TC de crânio sem contraste normal. ECG em ritmo sinusal. O exame a ser solicitado a seguir, com maior impacto na conduta, é:

A) Angiotomografia cervical e intracraniana

B) Ecocardiograma transtorácico com microbolhas

C) Eletroencefalograma de rotina

D) Pesquisa de trombofilias hereditárias

---

41 Homem de 56 anos, tabagista e dislipidêmico, procura o pronto-socorro às 9 h porque, nos últimos 3 dias, teve três episódios de dor retroesternal em aperto ao caminhar rápido, com 10 a 15 minutos de duração e alívio com repouso; o último foi às 6 h. No momento, está sem dor. Exame: PA 134×82 mmHg, FC 74 bpm, ausculta cardíaca e pulmonar normais. ECG atual: ritmo sinusal, sem supradesnivelamento do segmento ST, com ondas T negativas, profundas e simétricas de V2 a V4 e ondas R preservadas nas precordiais; ECG de 1 ano atrás sem essas alterações. Troponina ultrassensível na chegada e após 2 horas: 5 e 6 ng/L (referência até 14). A conduta mais adequada é:

A) Angiotomografia de coronárias

B) Teste ergométrico após 12 horas sem dor

C) Cineangiocoronariografia em até 24 horas

D) Cintilografia de perfusão miocárdica

---

42 Mulher de 81 anos, com fibrilação atrial permanente, insuficiência cardíaca com fração de ejeção de 35% e doença renal crônica (creatinina basal 1,8 mg/dL), é trazida por náuseas, anorexia e confusão há 4 dias. Há duas semanas o cardiologista acrescentou amiodarona por palpitações. Usa ainda furosemida, espironolactona 25 mg, sacubitril-valsartana, bisoprolol 2,5 mg e digoxina 0,25 mg/dia. PA 102 × 64 mmHg, FC 48 bpm. Potássio 5,9 mEq/L, creatinina 2,3 mg/dL, magnésio 1,9 mg/dL, TSH normal. ECG: ritmo regular de 48 bpm, sem ondas P visíveis, QRS estreito e infradesnivelamento côncavo do ST em V5 e V6. A causa mais provável do quadro é:

A) Hipercalemia pela espironolactona

B) Intoxicação digitálica

C) Bradicardia pelo betabloqueador

D) Hipotireoidismo pela amiodarona

---

43 Mulher de 46 anos, com lúpus eritematoso sistêmico, peso de 50 kg e taxa de filtração glomerular estimada de 38 mL/min/1,73 m², vai iniciar hidroxicloroquina; o exame oftalmológico basal é normal. Segundo a Academia Americana de Oftalmologia, a dose diária máxima e a periodicidade do rastreio de retinopatia são, respectivamente:

A) 250 mg / anual desde o início

B) 400 mg / anual desde o início

C) 250 mg / anual após 5 anos

D) 400 mg / anual após 5 anos

---

44 Mulher de 49 anos, com carcinoma ductal invasivo de mama HER2 positivo, estádio II, operada, recebeu doxorrubicina e ciclofosfamida (4 ciclos) e está no 5º mês de trastuzumabe adjuvante a cada 3 semanas. Ecocardiograma antes do trastuzumabe: fração de ejeção de 63%. No ecocardiograma de controle de hoje, realizado na véspera do próximo ciclo, a fração de ejeção de 37%, com hipocinesia difusa. Está assintomática, sem dispneia ou edema; PA 118 × 72 mmHg, FC 76 bpm, sem estertores, sem turgência jugular. BNP 210 pg/mL; troponina normal. A conduta mais adequada é:

A) Manter o trastuzumabe sem mudanças

B) Suspender definitivamente e não reintroduzir

C) Suspender por ora, com IECA e betabloqueador

D) Manter o trastuzumabe com IECA e betabloqueador

---

45 Mulher de 71 anos teve o primeiro episódio de diarreia por Clostridioides difficile há 7 semanas, após cefalosporina para pielonefrite, tratado com vancomicina oral 125 mg de 6/6 horas por 10 dias, com resolução completa em 4 dias. Há 3 dias, 12 dias após o fim da vancomicina e sem novo antibiótico, voltou a ter 6 evacuações líquidas por dia, com cólica e sem sangue. Usa omeprazol 20 mg/dia desde aquela internação. Exame: T 37,5 °C, PA 128 × 74 mmHg, abdome flácido, sem distensão. Leucócitos 12.400/mm³, creatinina 0,9 mg/dL (basal 0,8 mg/dL), albumina 3,6 g/dL. GDH e toxinas A/B positivas nas fezes. Além de reavaliar o omeprazol, o tratamento mais adequado é:

A) Transplante de microbiota fecal

B) Metronidazol oral por 14 dias

C) Vancomicina oral por 10 dias

D) Fidaxomicina oral por 10 dias

---

46 Mulher de 46 anos foi operada há 8 meses de macroadenoma hipofisário não funcionante e evoluiu com hipopituitarismo. Usa hidrocortisona 15 mg/dia, levotiroxina 75 mcg/dia desde a cirurgia e, há 3 meses, estradiol oral para a deficiência gonadotrófica. Queixa-se de cansaço, constipação, intolerância ao frio e ganho de 4 kg nos últimos meses. Exame: PA 112 × 70 mmHg, FC 58 bpm, pele seca, fase de relaxamento dos reflexos lentificada. Exames: TSH 0,9 mUI/L (VR 0,4 a 4,0), T4 livre 0,62 ng/dL (VR 0,9 a 1,8), sódio 138 mEq/L, glicemia 86 mg/dL. Ressonância de sela de controle há 1 mês: sem tumor residual. A conduta mais adequada neste momento é:

A) Manter a dose, pois o TSH está normal

B) Reduzir a hidrocortisona para 10 mg/dia

C) Teste com ACTH antes de ajustar

D) Aumentar a levotiroxina pela T4 livre

---

47 Homem de 24 anos, com hemofilia A grave e inibidor de alto título (último título de 14 UB/mL), sem resposta à imunotolerância feita na infância. Há 1 ano está em profilaxia com injeção subcutânea semanal de um anticorpo monoclonal biespecífico, com queda importante dos sangramentos. Hoje, após cair de bicicleta, apresenta hemartrose do joelho direito, com dor intensa, joelho tenso e quente e flexão limitada. PA 128/76 mmHg, FC 96 bpm. Exames: Hb 13,4 g/dL, plaquetas 244.000/mm³, TTPa 29 segundos (VR 25 a 35). O agente hemostático mais adequado para este episódio é:

A) Concentrado de fator VIII em dose alta

B) Complexo protrombínico parcialmente ativado

C) Plasma fresco congelado

D) Fator VII ativado recombinante

---

48 Homem de 29 anos tem hematúria microscópica descoberta em exame admissional. Nunca teve hematúria macroscópica. Sem edema, sem lesões cutâneas, sem artralgia ou dor abdominal. PA 122/76 mmHg em três consultas, com MAPA normal. Creatinina de 1,0 mg/dL (TFGe de 98 mL/min/1,73 m²), estável em três dosagens nos últimos 4 meses; proteinúria de 0,3 g/24 h, confirmada em nova coleta; C3 e C4 normais; FAN, ANCA e sorologias para hepatites B e C e HIV negativos. Não usa medicações. A biópsia renal mostra proliferação mesangial com depósitos dominantes de IgA na imunofluorescência, hipercelularidade endocapilar em alguns glomérulos e crescentes celulares em 2 de 24 glomérulos, com fibrose intersticial inferior a 10%. A conduta mais adequada neste momento é:

A) Pulsoterapia e ciclofosfamida

B) Budesonida de liberação entérica

C) Seguimento clínico e laboratorial

D) Prednisona em dose reduzida

---

49 Homem de 63 anos, com adenocarcinoma de cólon e múltiplas metástases hepáticas, portador de cateter venoso totalmente implantado, está em pausa de quimioterapia há 5 semanas. Há 3 semanas tem febre diária de até 38,6 °C, no fim da tarde, com sudorese, sem calafrios, e mantém-se bem entre os picos. Recebeu ceftriaxona por 7 dias e, depois, piperacilina-tazobactam por 5 dias, sem nenhuma mudança na curva térmica. Exame: FC 92 bpm, PA 126 × 80 mmHg, sítio do cateter sem hiperemia ou secreção, sem sopros, hepatomegalia nodular indolor. Exames: leucócitos 9.100/mm³ com neutrófilos de 6.300/mm³, PCR 9,2 mg/dL, procalcitonina 0,08 ng/mL, três pares de hemoculturas pareadas do cateter e periféricas negativas, urocultura negativa. TC de tórax e abdome: metástases hepáticas maiores que no exame anterior, sem coleções, abscessos ou trombose. O diagnóstico mais provável é:

A) Neutropenia febril

B) Febre neoplásica

C) Abscesso hepático piogênico

D) Infecção do cateter implantado

---

50 Mulher de 74 anos, com doença de Parkinson há 9 anos, usa levodopa/benserazida 200/50 mg 4 vezes ao dia, dose estável há 2 anos. Por discinesias de pico de dose, o neurologista acrescentou amantadina 100 mg de 12/12 horas há 3 semanas, com boa resposta. Há 5 dias passou a ver 'crianças e bichos' no quarto à noite, com crítica parcial, e fica confusa à tarde; está mais sonolenta e surgiu livedo reticular nas pernas. Tem também diabetes tipo 2 e doença renal crônica (creatinina 2,1 mg/dL, TFGe 23 mL/min/1,73 m²). Tax 36,7 °C, PA 128/70 mmHg. Urina: leucócitos 25 por campo, nitrito positivo; urocultura com mais de 100.000 UFC/mL de E. coli; sem disúria, sem febre. Sódio 138 mEq/L, glicemia 142 mg/dL. A causa mais provável do quadro atual é:

A) Infecção do trato urinário

B) Demência da doença de Parkinson

C) Excesso de levodopa

D) Acúmulo de amantadina

FOLHA DE RESPOSTAS

Simulado 6

Nome: _____ Data: ___/___/_____ Início: ___h___ Fim: ___h___

1	A	B	C	D	2	A	B	C	D	3	A	B	C	D	4	A	B	C	D
5	A	B	C	D	6	A	B	C	D	7	A	B	C	D	8	A	B	C	D
9	A	B	C	D	10	A	B	C	D	11	A	B	C	D	12	A	B	C	D
13	A	B	C	D	14	A	B	C	D	15	A	B	C	D	16	A	B	C	D
17	A	B	C	D	18	A	B	C	D	19	A	B	C	D	20	A	B	C	D
21	A	B	C	D	22	A	B	C	D	23	A	B	C	D	24	A	B	C	D
25	A	B	C	D	26	A	B	C	D	27	A	B	C	D	28	A	B	C	D
29	A	B	C	D	30	A	B	C	D	31	A	B	C	D	32	A	B	C	D
33	A	B	C	D	34	A	B	C	D	35	A	B	C	D	36	A	B	C	D
37	A	B	C	D	38	A	B	C	D	39	A	B	C	D	40	A	B	C	D
41	A	B	C	D	42	A	B	C	D	43	A	B	C	D	44	A	B	C	D
45	A	B	C	D	46	A	B	C	D	47	A	B	C	D	48	A	B	C	D
49	A	B	C	D	50	A	B	C	D										